

婴幼儿睡眠学习完全指南

基于专业医生与循证医学的育儿建议

一、核心科学观念：睡眠学习 (Sleep Learning)

并非“放任不管”	睡眠学习是教宝宝学会自主入睡和在半夜醒来后自行接睡的过程，而非冷酷地忽视宝宝。
安全性证明	科学研究表明，睡眠训练不会损害亲子依恋关系，也不会对宝宝的情绪健康或压力激素（皮质醇）水平产生负面影响。
对父母的好处	睡眠充足的父母患产后抑郁的风险更低，婚姻满意度更高，且能提供更高质量的育儿陪伴。

二、第一阶段：新生儿期 (0-3个月) —— 建立习惯

阶段目标	此阶段的目标不是让宝宝睡整觉，而是帮助他们区分昼夜并建立初步规律。
光照调节	白天让宝宝多接触自然光；晚上喂奶和换尿布时保持灯光昏暗。
掌控“清醒窗口”	0-12周宝宝的清醒时间通常只有45-90分钟。一旦错过窗口，宝宝会因为过度疲劳而更难哄睡。
吃饱是睡眠的前提	确保宝宝在清醒状态下吃饱。如果宝宝边吃边睡，可以尝试挠脚心或换尿布来唤醒他们，确保摄入足够奶量，这样才能睡得更久。
安抚“5S”法	包裹 (Swaddle)：包紧双臂模拟子宫感；侧卧/俯卧安抚 (Side/Stomach)：仅限安抚时，睡觉必须仰卧；嘘声 (Shush)：使用比宝宝哭声稍大的白噪音；摇摆 (Sway)：有节奏地轻晃；吸吮 (Suck)：使用安抚奶嘴 (如果宝宝接受)。
白天“叫醒”原则	白天每2-3小时叫醒喂奶，以确保全天大部分热量在白天摄入；晚上则不主动叫醒，除非医生另有要求。

三、第二阶段：睡眠学习 (4-6个月+) —— 六步法

开始条件	当宝宝满4个月、体重正常且每天摄入至少24盎司（约710毫升）奶量时，可以开始此过程。
第一步：充足的白天营养	确保宝宝在白天每2-3小时吃一次，把胃口留在白天。
第二步：优化环境	房间应黑暗、安静、温度适中，并使用白噪音掩盖杂音。
第三步：固定睡前程序	每晚7点至8点之间入睡。流程如：洗澡、喂奶、读书、穿睡袋、唱固定的摇篮曲。

第四步：执行“渐进式安抚”	把清醒但有睡意的宝宝放下，离开房间。如果哭闹，按5分钟、10分钟、15分钟的间隔进去查看。关键：进去只停留20-30秒，仅用语言和轻触安抚，绝对不要抱起来。
第五步：半夜醒来的处理	采用与睡前相同的安抚方案。
第六步：坚持到底	通常需要2到5个晚上见效，全家人必须保持百分之百的一致性。

四、特殊情况与常见疑问

半夜拉粑粑了怎么办？	必须抱起来换尿布，这是为了防止严重的尿布疹。换完后保持安静黑暗，直接放回婴儿床继续程序。
生病或长牙期间	这是“响应式育儿”的时刻。如果宝宝真的不适（如发烧），应及时干预、抱起和照顾。
同屋睡或有兄弟姐妹	可以进行训练。如果担心吵到大孩子，可以提前沟通。宝宝们很快会习惯彼此的干扰并学会互相忽略。
关于安抚奶嘴	如果决定开始睡眠学习，可以同时戒掉奶嘴，或者在床上多放几个让宝宝自己找。不要反复进屋帮宝宝捡奶嘴塞回去。

五、给家人的心里话

宝宝在学习新技能	就像学走路会摔跤一样，学习睡觉时哭泣是宝宝表达挫折感的一种方式。
父母的底气	当宝宝哭闹时，请告诉自己：“宝宝是被爱着的、是吃饱了的、是干爽的，他/她可以做得得到。”
长远的幸福	几晚的坚持将换来全家未来几年的优质睡眠和更健康的亲子关系。

注：本指南基于《The Doctors Bjorkman》视频内容整理，仅供教育参考。具体医学问题请咨询您的儿科医生。